

施行心血管手术时麻醉药与其他药物相互作用问题应深入研究

美国西雅图消息：得克萨斯大学麻醉学教授Robert Merin在麻醉学家学会的年会上说，当病人面临心血管外科手术时，万一当前所用药物与麻醉药有相互影响时，麻醉师是否应命令停用全部其他药物？争论更多的是：如果想使病人更安全的度过围手术期，应否使用新药？他说，如有可能性，应对高血压病人进行研究。

Merin强调，最近临床研究彻底改变了他对手术前停用单胺氧化酶（MAO）抑制剂的看法。他说，必须对这些药物进行再研究；应记住这些药物几乎是专用于严重抑郁症的病人。在某种意义上说，这些药物用来治疗危及生命的疾病——企图自杀者。

近期的及回顾性研究表明，用MAO抑制剂的人在围手术期中的发病率无差异。

Merin认为，如果抑郁症病人情况严重，应继续用这些药。这与他以前的观点及多数其他药理学家观点不同。

Merin说，至少有一种药物在围手术期开始前应考虑。一种肾上腺素能主动肌抗高血压药特别值得注意。氯压定是一种非常有趣的药物，且有大量的证据表明，在围手术期应开始用此药。它能明显平定用高血压病人的血压及心率，减少麻醉药用量。

一项研究表明，在病人施行冠状动脉搭桥术中，氯压定能降低麻醉药的用量，改进肾上腺素能的稳定性。

Merin认为，这是麻醉学家应着手药疗研究的一个领域。药疗不只限于高血压病人（用氯压定治疗的病人），亦可用于施行心脏手术或广泛的非心脏手术病人。

Merin的其他建议如下：

- 根据目前的考虑，对于施行手术治疗的病人应继续用抗高血压药。尽管这方面的研究还极少，但这是一个直觉的想法。

- 一度认为术前继续用 β -阻滞剂会危及生命。现已证实这种论点是不能成立的。甚至内科医师已接受这一事实，即病人如果没有明显的心血管病，不应撤除 β -阻滞剂。

- 据Merin意见，多数病例应继续用钙阻滞剂。如果医生适当地给予病人麻醉，适量用钙通道阻滞剂，对病人有益，就应继续用药。

- 使用洋地黄仍有争论。Merin说，许多单位往往停用洋地黄，因为担心在心肺转流术时失钾。由于输注技术和研究方法的改进，失钾不会过多。

Merin自己的意见是：心脏手术病人如用洋地黄受益，应继续使用。对于施行心脏手术的病人继续服用洋地黄，对于非心脏手术病人不停药都无意义。

- β -阻滞剂似应在手术前开始服用。Merin以两项研究为例说明，服用 β -阻滞剂（无论是单用或是与钙阻滞剂联用）的病人，围手术期内心肌缺血的发生率较低。

- 如果停用洋地黄尚有争论，那么，开始使用如何？有些研究证实，许多冠心病病人术前如服用洋地黄，术后心室功能立即转好。另一项研究发现，直至术后3天，心律不齐的发病率较低；并能发现经冠状动脉搭桥术的病人用洋地黄后有明显的预防效果。

菲琳摘译自Med Post 25(43):48, Dec.1989

君平校